

철결핍성 빈혈, 원인을 찾고 채워주면 회복됩니다

Iron Deficiency Anemia (IDA) — 원인·진단·철분제·식이·재발 방지

가장 흔한 빈혈 — 한국 가임기 여성 5명 중 1명

전 세계 빈혈의 약 50%가 철결핍성. 남성·폐경 후 여성에서는 출혈 원인을 반드시 찾아야 합니다

20%

WHY SOURCE MATTERS

빈혈은 "결과"이지 진단이 아닙니다. 특히 남성·폐경 후 여성·노인의 철결핍성 빈혈은 약 10%에서 위·대장암 등 소화관 출혈이 원인입니다. 철분제만 보충하지 말고 반드시 출혈원을 찾아야 합니다 (위·대장 내시경 권고).

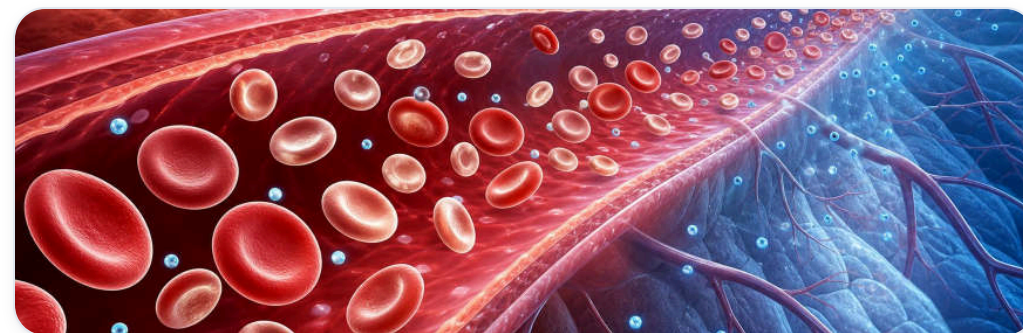
한국 가임기 여성의 철결핍성 빈혈 유병률 — 생리 출혈·임신·식이 부족이 누적되어 발생합니다.

철결핍성 빈혈 (IDA) 이란

체내 저장철 고갈 → 헤모글로빈 합성 부족 → 적혈구 크기·산소운반능력 감소

철은 헤모글로빈의 중심 — 부족하면 작고 창백한 적혈구가 만들어져 산소 운반이 떨어집니다.

철 손실(출혈·생리)이나 섭취/흡수 저하가 지속되면 ① 저장철(페리틴)이 먼저 떨어지고 → ② 운반철(혈청철·TSAT)이 줄고 → ③ 적혈구 크기(MCV)가 작아지고 → ④ 마침내 헤모글로빈(Hb)이 떨어집니다. 페리틴이 가장 민감한 지표라 Hb가 정상이어도 페리틴 ↓ 만으로 진단·치료할 수 있습니다.



MOST SENSITIVE MARKER

Ferritin

< 30 ng/mL이면 철결핍 강력 시사 (염증 동반 시 < 100).

RBC MORPHOLOGY

MCV ↓ · RDW ↑

소구성·이형 적혈구 — 도말에서 시각적으로도 확인 가능.

왜 철이 부족해지나 — 6가지 흔한 원인

"손실 > 흡수" 또는 "수요 > 공급" — 진단 후 반드시 원인을 평가합니다

LOSS · 01

생리 과다 (월경과다)

가임기 여성에서 가장 흔함. 한 번 사용량 ≥ 21 일 이상, 패드/там폰 잦은 교체, 큰 핏덩어리 시 의심. 부인과 평가 권고.

LOSS · 02

소화관 출혈 (위·대장)

남성·폐경 후 여성·노인에서 1순위 의심. 위궤양·위암·대장암·치질·기생충. **내시경 평가 필수.**

INTAKE · 03

식이 부족 / 채식주의

붉은 고기·내장 섭취 부족. 비건/베지테리언, 노인 식사량 감소, 아동 우유 의존 식이.

ABSORPTION · 04

흡수장애

위절제술·헬리코박터·셀리악병·만성 위염·PPI 장기 복용. 십이지장에서 철 흡수가 이뤄지므로 위 산도/구조 변화에 민감.

DEMAND · 05

임신·수유·청소년 성장

임신 중 철 수요 ~3배 증가. 모체 비축이 부족하면 산후 빈혈 + 태아 발달 영향. 정기 산전 검사 필요.

OCCULT · 06

잠재성 출혈 — 악성 가능

증상 없이 진행되는 위장관 종양·신장 종양. 50세 이상 신규 IDA는 **대장암 평가 필수.**



증상 — 천천히 진행해서 본인은 잘 모릅니다

서서히 빈혈이 진행하면 몸이 적응해 증상이 약합니다. 적은 활동에도 평소보다 힘들면 의심하세요

SYMPTOM · 01

피로 · 무기력

가장 흔한 증상. 잠을 푹 자도 피곤하고, 평소 하던 일이 버겁게 느껴집니다.

SYMPTOM · 02

운동 시 호흡곤란

계단 오르기·빠른 걷기·집안일에서 평소보다 숨참. 산소 운반 능력 저하의 직접 징후.

SYMPTOM · 03

어지러움 · 두통

기립 시 눈앞 캄캄·잦은 두통. 심하면 실신. 뇌 산소 부족의 신호.

SYMPTOM · 04

손톱 변화 · 머리카락 빠짐

손톱이 잘 부서지고 손가락 모양(spoon nail) · 머리카락 다량 탈모. 만성 철결핍의 외부 단서.

SYMPTOM · 05

이식증 · 얼음 깨물기

얼음·흙·종이·녹말 같은 비식품을 갈망(pica). 철결핍의 특이 증상.

SYMPTOM · 06

하지 불편 · 가슴 두근거림

하지불안증후군(RLS) 악화·가만 있어도 심장이 두근거림. 심한 빈혈에서.

진단 — 4가지 수치로 확정

Hb 단독으로는 진단 어려움. 페리틴·TSAT을 반드시 함께 봅니다

PANEL · 01

헤모글로빈 (Hb)

남 < 13.0 / 여 < 12.0 g/dL = 빈혈. Hb 정상이어도 페리틴 ↓ 면 철결핍 단독으로 진단 + 치료 가능.

PANEL · 02

평균적혈구용적 (MCV)

< 80 fL = 소구성. 철결핍의 전형 패턴이지만 초기엔 정상 가능. RDW ↑ (적혈구 크기 다양)도 동반.

KEY · 03

페리틴 (Ferritin) — 가장 민감

< 30 ng/mL = 철결핍 거의 확정. 염증·간질환 동반 시 < 100. 저장철 상태를 직접 반영.

KEY · 04

트랜스페린포화도 (TSAT)

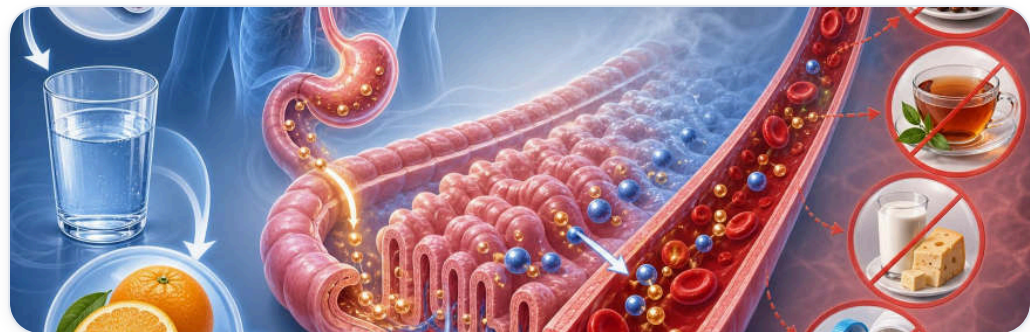
혈청철 ÷ TIBC × 100. < 16% = 철결핍. 페리틴 정상이고 염증 의심 시 보조 지표로 사용.

1차 치료 — 경구 철분제 + 흡수 최적화

대부분의 환자는 경구 철분제로 회복. 격일 복용이 매일 복용보다 흡수율이 높을 수 있습니다

철분제는 공복 + 비타민 C 동시 복용이 흡수를 최대로 끌어올립니다. 차·우유·칼슘제와는 시간 간격을 두세요.

성인 권장 용량은 원소철 100~200mg/일. 최근 연구는 격일 복용이 일일 복용보다 헵시딘 차단을 피해 흡수율이 더 높을 수 있음을 시사합니다. 위장 부작용(메스꺼움·변비·검은 변)이 흔해 식사 직후나 저용량부터 시작합니다. Hb 정상화에 약 2개월, 페리틴 회복에 추가 3~6개월 필요. **최소 6개월 이상** 복용해 저장철까지 채워야 재발을 막습니다.



HB 회복 시점

2 ~ 8주

1주 망상적혈구 ↑, 4~8주 Hb 정상화. 4주 후 재검으로 반응 확인.

최소 치료 기간

6 개월

Hb 정상화 후에도 페리틴 ≥ 50까지 보충 — 재발 방지.

경구로 부족할 때 — 정맥 철분제 + 원인 평가

위장 부작용·흡수 장애·심한 빈혈·임신 후기에서 정맥 철분제가 빠른 회복을 돕습니다

INDICATION · 01

정맥 철분제 (IV iron)

경구 불내성·흡수장애·심한 결핍·임신 28주 이후·만성콩팥병, ferric carboxymaltose·iron sucrose 등. **아나필락시스 드문 부작용 주의.**

RED FLAG · 02

원인 평가 — 출혈원 찾기

남성·폐경 후 여성·50세 이상은 위·대장 내시경 필수. 양성 출혈원 없으면 캡슐내시경·소장 평가 고려.

SUPPORT · 03

부작용 관리

변비·메스꺼움 → 격일 복용·저용량 시작·식사 직후·식이섬유·수분. 검은 변은 정상 — 출혈과 구별.

SUPPORT · 04

수혈 적응증

증상 동반 Hb < 7~8 g/dL 또는 혈액학적 불안정. 비응급 IDA에서 수혈은 1차 선택이 아닙니다.

철분 흡수를 돕는 식사 vs 막는 식사

철분제와 함께 복용 시 흡수를 ↑↑하는 식품과, ↓↓ 떨어뜨리는 식품을 구분해 시간 배치합니다

DO · 흡수 증진
철분제와 함께·또는 가까이

- **비타민 C 풍부 식품** — 오렌지·키위·딸기·피망·브로콜리
- **붉은 고기·간·내장** — 헴철, 흡수율 25%
- **달걀·생선·가금류** — 단백질 + 철 함유
- **철분 강화 시리얼** — 아침 식사 보조
- **녹황색 채소** — 시금치·근대 (Vit C와 함께)
- **콩·렌틸·두부** — 비헴철, 다양한 식단

DON'T · 흡수 저해
철분제 복용 후 2시간 이상 간격

- **차·커피** — 탄닌이 흡수 50~80% ↓
- **우유·요거트·치즈** — 칼슘이 경쟁 흡수
- **칼슘제·제산제·위장약** — 위 산도 ↓
- **통곡물·견과 다량** — 피틴산 흡수 저해
- **적포도주 과량** — 폴리페놀
- **철분제 + 갑상선약 동시 복용** — 시간 분리

즉시 평가가 필요한 신호 — 단순 빈혈로 보지 말 것

아래 상황은 출혈원·악성 평가가 필요하며, 철분제만 보충하면 안 됩니다

URGENT · 01

남성 IDA · 폐경 후 여성 IDA

생리가 없는 상태에서 IDA가 발생하면
위·대장 출혈을 1순위로 의심. 내시경
평가 필수.

URGENT · 02

흑색변 · 혈변 · 토혈

위·소장 출혈은 검은 짜장 같은 변, 대장
출혈은 붉은 변. 즉시 내원·내시경.

URGENT · 03

체중감소·식욕저하·복통 동반

소화관·림프계 악성 가능성. CT 또는
내시경 우선.

WATCH · 04

철분제 4주 후 반응 없음

Hb 1 g/dL 이상 ↑ 안 보임 → 진단
재검토·흡수장애·진행성 출혈·
만성질환성 빈혈 동반 가능.

WATCH · 05

갑작스러운 호흡곤란·흉통

심한 빈혈에서 심부전·협심증 악화 가능.
Hb < 7~8 + 증상 시 응급실.

WATCH · 06

임신 중 Hb < 9

조산·저체중아 위험 ↑. 산과 협진 +
정맥 철분제 고려.



환자 실천 7가지 — 복용·식이·추적

제대로 복용하고 추적하면 대부분 회복하며 재발도 막을 수 있습니다

01

철분제 공복 또는 식사 직후 — 비타민 C(과일·주스)와 함께. 차·우유·칼슘은 2시간 이상
간격.

02

매일 또는 격일 복용 — 의료진 처방대로. 위장 부작용 심하면 격일 복용 시도.

03

검은 변은 정상이지만 **피가 섞인 변**은 즉시 내원.

04

1개월 후 Hb 재검 → Hb 1 g/dL 이상 ↑ 확인.

05

Hb 정상화 후에도 6개월 이상 복용 — 페리틴 ≥ 50 까지.

06

붉은 고기·간 주 2~3회 또는 식물성 단백질 + 비타민 C 다양화.

07

재발 시 원인 재평가 — 생리·소화관·약물·식이 다시 점검.

원인을 찾고 6개월 이상 채우면 완치됩니다

빈혈은 결과이지 진단이 아닙니다 — 원인을 함께 평가하면 재발 없이 회복합니다

광교바른내과 진료 안내

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층

☎ 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진



다시 보기 · 카톡 공유